



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مني عيد بدر علي
المحافظة : الفيوم
الحى / المدينة : اطسا
رقم البطاقة : 27812050106329 رقم التليفون : 01004620878
العنوان : ممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 05-12-1978 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منى عيد بدر علي National ID: 27812050106329	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحديد الشخصية

ميني
 عبد بدر علي
 مصرية عرفة
 مركز الطنطا، اللبوم

٢٧٨١٢٠٥٠١٠٢٣٢٩
 LB6980676


 ٢٠٢٥/٠٣/٠١ ٢٧٨١٢٠٥٠١٠٢٣٢٩

دبلوم صناعة
 أنش
 معمر فوزي أحمد عايق
 البطاقة مصرية حتى ٢٠٢١/٠٢/٠١







Ministry of Health & Family Welfare
Government of India



(CA)

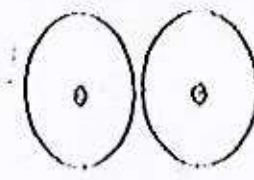
MDT FORM

19/7/2022

1-215-ANA

1-01112091

Name	Shree S. S. S.	MRN	192-5-55
Age	43 y	ID	SVNS-01-7469
Menopausal status		Phone	1-215-ANA
OCP		Medical status	
Co morbidity	DMT	Family history	

Post NACT				Clinical Data	
Bx:	Post (L) MRM	R		L	
IB: 1/P	PR1k:	HER2:	K167:		
+	+	+	+		
Sonomammography:					
Postul remove				Free margins	
				LN (17/18)	
Metis Workup				TNM	
13-nc scan				0/2 N3 1/1	
Recommendations:					

MDT OUTCOME & PLAN

To complete 1 year of TDM,
- Penicillin - 201. dex
- po KT

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	SIGNATURE	RADIOLOGY	PATHOLOGY
Agulsh		19/7/2022		

Patient Name : **الأستاذة / منى محمد علي**
 Patient No. : **27812050106329**
 Path No. : **60/2022**
 Sex : **Female**
 Age : **43 Y**
 Referring Doc :

Request No. : **13001351**
 Request Date : **29/01/2022**
 Verification Date : **06/02/2022**
 Financial Category : **ناتئة الدولة - اورد ام ديار السلام**
 Department : **Out Patient**
 Registered by : **marwa mohamed voliss**

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast 12 o'clock suspicious lesion

Nature of the specimen:

Slide revision

Gross Examination:

1 block (9011 21) & 3 slides

Microscopic examination

- Histological type: Invasive duct carcinoma with micropapillary features.
- Grade 2 (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): G (3+2+1)
- Angiolinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Additional pathologic findings: No calcification

Diagnosis:

Left breast lesion; Slide revision:

Invasive duct carcinoma grade 2, with micropapillary features.

IHC:

ER: Moderate nuclear reaction in about 80% of tumour cells. Positive (Allred score 7/8)

PR: Moderate nuclear reaction in about 85% of tumour cells. Positive (Allred score 7/8)

Her-2: Strong complete membrane reaction in 10% of tumour cells. Positive, score 3+

Prof. Dr. Amal Hareedy

Dr. Abdulrahman Ibrahim

Verified by
 abdelrahman ibrahim

Printing Date : 06/02/2022 13:54:02

Page 1 of 2

Printing By : dr.menna atef



Patient Name : الأمثلة / منى عبد بدر علي	Request No. : 13001869
Patient No. : 27812050106329	Request Date : 20/06/2022
Path No. : 1693/2022	Verification Date : 05/07/2022
Sex : Female	Financial Category : فئة الدولة - لوريم بار السلام
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

LT breast cancer , Post NACT.

Nature of the specimen:

LT MRM

Gross Examination:

- Procedure: LT MRM specimen measured 25x23x4cm, covering skin piece measured 22x10cm. Nipple and areola were unremarkable grossly. Axilla measured 11x4cm (separate in the same container).
- Tumor extent: A rubbery greyish white area.
- o Size: 5x3x3cm
- o Skin involvement: No
- Lymph nodes number and size: 18 LN.
- Additional findings: No

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive micropapillary carcinoma, tumor necrosis index is +/- 60%, 40% cellularity.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1)
- Angiolinvasion: Yes
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in (17/18) LN, with focal capsular infiltration.
- Resection Margins: Free deep margin
- Free nipple and areola
- Histologic response to therapy: Pathological partial response
- Additional pathologic findings: Inconspicuous perineural invasion.

Verified by :

abdelrahman ibrahim

Printing Date : 16/07/2022 12:09:31

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name: Mona Eid Badr Ali	Date : 13/06/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 193/2022	Pat ID: 13641

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM.

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is scattered fibroglandular parenchyma (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Right LIQ circumscribed oval shaped dense mass
- Complementary ultrasound also showed right 4O'clock circumscribed oval shaped hypoechoic solid mass, measuring about 23x12mm
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- right benign looking mass stationary since 11/2022

Yours truly

Signature Dr. Walaa Abdelkazez

13/06/2023 5:33 PM



Patient Name: Mona Red Badr Ali		Patient Gender: Female
ID: Q30537	DATE: 1/11/2022 1:45:50 PM	
TO: IMMUNOSKELETAL SCINTIGRAPHY		

Clinical history

- A-43-year-old female patient with a history of left breast cancer for metastatic work up.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings:

- ? No abnormal active or cold osseous lesions detected to account for bone metastases.
- ? Degenerative changes all over spine are noted.
- ? Osteoarthritic features of both shoulders are also observed.

as Impression:

- ? The skeleton is free from metastases.

Ass.Prof.Dr.Maha Abd El.kareem , MD

Dr.Mohamed Khaled

Patient Name: Mona Eid Badr Ali	Date : 01/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 193/2022	Pat. ID: 13641

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

****A known case of left breast cancer**

I Chest: -

- Left mastectomy with clear operative bed , no masses , no collection .
- Right breast well defined mass RIQ measuring 20 x 12 mm for sonomammographic correlation
- Bilateral prominent axillary lymph nodes .
- Left upper lobe subpleural reticulations likely post radiotherapy .
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Carinal /subcarinal partially calcified lymph node 7 X 5 cm.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Enlarged heterogenous both thyroid lobes .

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged in size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Diverticular disease of sigmoid and descending colon.

Patient Name: Mona Eid Badr Ali	Date : 01/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 193/2022	Pat. ID: 13641

- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

III The scanned skeleton:

- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

Opinion:

- Right breast well defined mass RIQ for sonomammographic correlation .*
- ***No hepatic , pulmonary or bony metastatic deposits***

Dr. Reham Khedr, MD

Signature Reeham.Khader

03/11/2025 9:58 AM